🎓 CALICUT UNIVERSITY FYUGP · MODULE 1 · SOCIAL INDICATORS

MODULE 1 · PART 6: Indicators of Development: Health and Education

മൊഡ്യൂൾ 1 · ഭാഗം 6: വികസന സൂചികകൾ: ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും

1. Health and Education as Pillars of Human Capital Formation

1. മാനവ മൂലധന രൂപീകരണത്തിന്റെ നെടുംതൂണുകൾ: ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും

Modern development theory treats human beings not merely as instruments of production, but as the supreme objective of all economic activity. As pioneered by Nobel laureates **Theodore Schultz** and **Gary Becker**, **Human Capital Formation** refers to the process of acquiring and increasing the knowledge, skills, technical capabilities, and physical fitness of the national population.

Health and education are mutually reinforcing: a healthy child learns efficiently in school, while an educated mother manages child nutrition and healthcare far more effectively. Together, they transform passive populations into dynamic, innovative economic contributors.

ആധുനിക വികസന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മനുഷ്യനെ വെറുമൊരു ഉൽപ്പാദന ഉപകരണമായി മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യമായാണ് കാണുന്നത്. നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാക്കളായ **തിയോഡോർ ഷൂൾട്സ്**, **ഗാരി ബെക്കർ** എന്നിവർ മുന്നോട്ടുവെച്ച **മാനവ മൂലധന രൂപീകരണം (Human Capital Formation)** എന്നത് ജനങ്ങളുടെ അറിവ്, നൈപുണ്യം, സാങ്കേതിക ശേഷി, ആരോഗ്യം എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്.

ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്: ആരോഗ്യവാനായ കുട്ടിക്ക് നന്നായി പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നു; വിദ്യാസമ്പന്നയായ അമ്മയ്ക്ക് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും പോഷകാഹാരവും മികച്ച രീതിയിൽ പരിപാലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇത് ജനങ്ങളെ കാര്യക്ഷമമായ ഉൽപ്പാദന ശക്തിയായി മാറ്റുന്നു.

2. Health as an Economic Investment & Productivity Engine

2. ആരോഗ്യം ഒരു സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതാ പ്രേരകവും

Expenditure on public health is not consumptive welfare drain; it is a high-return macroeconomic investment. A healthy workforce directly enhances national productivity by reducing absenteeism, prolonging active working lifespan, and elevating physical and cognitive stamina.

Conversely, endemic diseases (malaria, tuberculosis, malnutrition) sap national potential, forcing low-income families into catastrophic out-of-pocket medical expenditures that perpetuate intergenerational poverty traps. Robust health systems form the bedrock of economic resilience.

പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനായുള്ള ചെലവുകൾ വെറുമൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയല്ല, മറിച്ച് ഉയർന്ന വരുമാനം നൽകുന്ന മികച്ചൊരു മാക്രോ ഇക്കണോമിക് നിക്ഷേപമാണ്. ആരോഗ്യകരമായ തൊഴിൽ ശക്തി അസുഖങ്ങൾ മൂലമുള്ള അവധികൾ കുറയ്ക്കുകയും, തൊഴിൽ ആയുസ്സും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളും പോഷകാഹാരക്കുറവും ജനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ശേഷി കുറയ്ക്കുകയും കുടുംബങ്ങളെ വലിയ കടക്കെണിയിലേക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കും തള്ളിവിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ശക്തമായ ആരോഗ്യ സംവിധാനമാണ് സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുടെ അടിത്തറ.

3. Major Health Indicators: Life Expectancy, IMR and MMR

3. പ്രധാന ആരോഗ്യ സൂചികകൾ: ആയുർദൈർഘ്യം, ശിശുമരണ നിരക്ക് (IMR), മാതൃമരണ നിരക്ക് (MMR)

The physical health profile of a nation is benchmarked against three critical demographic indicators:

- **Life Expectancy at Birth**: Average number of years a newborn infant is expected to survive under prevailing mortality conditions. In India, life expectancy has climbed from **32 years in 1947** to over **70 years today**.
- **Infant Mortality Rate (IMR)**: Number of deaths of infants under one year of age per **1,000 live births**. It serves as an ultra-sensitive barometer of sanitation, clean drinking water, and maternal healthcare.
- **Maternal Mortality Ratio (MMR)**: Number of maternal deaths during pregnancy or childbirth per **100,000 live births**, reflecting institutional delivery access.

ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ നിലവാരം മൂന്ന് സുപ്രധാന സൂചികകളിലൂടെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു:

- **ജനനസമയത്തെ ആയുർദൈർഘ്യം (Life Expectancy)**: നിലവിലെ മരണനിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു നവജാത ശിശു ജീവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ശരാശരി വർഷങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിലിത് **1947 ലെ 32 വർഷത്തിൽ** നിന്ന് ഇന്ന് **70 വർഷത്തിന് മുകളിലേക്ക്** ഉയർന്നു.
- **ശിശുമരണ നിരക്ക് (IMR)**: ഒരു വർഷത്തിൽ ജനിക്കുന്ന **1,000 കുട്ടികളിൽ** ഒരു വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുൻപ് മരണപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം. കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം, പ്രാഥമിക ചികിത്സ എന്നിവയുടെ പ്രധാന അളവുകോലാണിത്.
- **മാതൃമരണ നിരക്ക് (MMR)**: പ്രസവത്തോടനുബന്ധിച്ച് **1,00,000 പ്രസവങ്ങളിൽ** മരണപ്പെടുന്ന അമ്മമാരുടെ എണ്ണം; മികച്ച പ്രസവചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

4. Nutrition, Food Security & Public Healthcare Infrastructure

4. പോഷകാഹാരം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ

Health outcomes are fundamentally anchored in childhood nutrition. Chronic undernutrition manifests in severe developmental deficits:

- **Stunting (Low Height-for-Age)**: Reflects long-term chronic undernutrition, stunting brain development and learning aptitude.
- **Wasting (Low Weight-for-Height)**: Indicates acute, severe starvation or recent debilitating infections.
- **Healthcare Infrastructure Pyramid**: Multi-tier institutional hierarchy comprising Sub-Centres, Primary Health Centres (**PHCs**), Community Health Centres (**CHCs**), and District Hospitals to ensure decentralized care.

കുട്ടികളിലെ പോഷകാഹാര നിലവാരമാണ് ഒരു ജനതയുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ അടിത്തറ. പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ:

- **വളർച്ചാ മുരടിപ്പ് (Stunting)**: പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉയരക്കുറവ്. ഇത് തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ചയെയും ബുദ്ധിവികാസത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നു.
- **ശരീരശോഷണം (Wasting)**: ഉയരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഭാരക്കുറവ്. കഠിനമായ പട്ടിണിയുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും ലക്ഷണമാണിത്.
- **പൊതുജനാരോഗ്യ ശൃംഖല**: സബ് സെന്ററുകൾ, പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ (**PHC**), കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ (**CHC**), ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ എന്നിവയടങ്ങുന്ന വികേന്ദ്രീകൃത ചികിത്സാ സംവിധാനം.

5. Flagship Government Interventions: Ayushman Bharat & Universal Healthcare
5. സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ: ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് & സാർവത്രിക ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം

To address the catastrophic burden of out-of-pocket medical expenses, the Government launched **Ayushman Bharat (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana – PM-JAY)**, resting upon twin strategic pillars:

- **Ayushman Arogya Mandir (Health & Wellness Centres)**: Transforming over **1,50,000 sub-centres** into comprehensive primary care hubs providing free essential drugs, diagnostics, and preventive maternal-child care.
- **PM-JAY Health Insurance**: World's largest government-funded health assurance scheme providing up to **₹5 lakh per family per year** for secondary and tertiary hospitalization to over **500 million** vulnerable citizens.

ചികിത്സാ ചെലവുകൾ ജനങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് തടയാൻ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ പദ്ധതിയാണ് **ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് (PM-JAY)**. ഇതിന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്:

- **ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ (Health & Wellness Centres)**: ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം സബ് സെന്ററുകളെ സമഗ്ര പ്രാഥമിക ചികിത്സ, സൗജന്യ മരുന്നുകൾ, പരിശോധനകൾ എന്നിവ നൽകുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു.
- **PM-JAY ഇൻഷുറൻസ്**: പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് കിടത്തിച്ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രതിവർഷം **₹5 ലക്ഷം രൂപയുടെ** സൗജന്യ ക്യാഷ്‌ലെസ്സ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്ന ബൃഹദ് പദ്ധതി.

6. Preventive Healthcare, Immunisation & Mission Indradhanush
6. പ്രതിരോധ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവെയ്പ് & മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ്

Preventive healthcare is infinitely more cost-effective than reactive hospital cure. Immunisation protects infants from fatal vaccine-preventable diseases including polio, measles, diphtheria, pertussis, tetanus, and hepatitis B.

Under **Mission Indradhanush**, targeted mop-up drives have rapidly expanded full immunisation coverage among pregnant mothers and unvaccinated infants across high-risk tribal and rural districts, dramatically curbing preventable child mortality nationwide.

രോഗം വന്നതിനു ശേഷമുള്ള ചികിത്സയേക്കാൾ ചെലവ് കുറഞ്ഞതും കാര്യക്ഷമവുമായ മാർഗ്ഗമാണ് രോഗപ്രതിരോധം. പോളിയോ, വില്ലൻചുമ, ടെറ്റനസ്, മീസിൽസ് തുടങ്ങിയ മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിരോധ കുത്തിവെയ്പുകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് (Mission Indradhanush) വഴി രാജ്യത്തെ ഗ്രാമീണ-ആദിവാസി മേഖലകളിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗർഭിണികൾക്കും സമ്പൂർണ്ണ വാക്സിനേഷൻ ഉറപ്പാക്കി ശിശുമരണ നിരക്ക് വൻതോതിൽ കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു.

7. Education as an Engine of Capability Enhancement: Amartya Sen's Perspective
7. വിദ്യാഭ്യാസവും ശേഷി വികാസവും: അമർത്യ സെന്നിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്

Education transcends mechanical vocational training. According to **Amartya Sen's Capability Approach**, education expands intrinsic human capability—the substantive freedom to choose a life one has reason to value.

Literacy empowers citizens to articulate political rights, navigate legal systems, challenge regressive social taboos, and access remunerative technological opportunities. In the words of **Dr. B.R. Ambedkar**, education is the prime instrument of social emancipation and equality.

വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് വെറുമൊരു ജോലി സമ്പാദിക്കാനുള്ള വഴി മാത്രമല്ല. **അമർത്യ സെന്നിന്റെ 'ശേഷി സമീപനം' (Capability Approach)** അനുസരിച്ച്, വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ശേഷികളെ വികസിപ്പിക്കുകയും മാന്യമായ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

അവകാശങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങാനും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാനും വിദ്യാഭ്യാസം പൗരന്മാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. **ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ** നിരീക്ഷിച്ചതുപോലെ സാമൂഹിക വിമോചനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം.

8. Literacy Dynamics: National Trajectory & Persistent Gender Disparities
8. സാക്ഷരതാ വളർച്ചയും നിലനിൽക്കുന്ന ലിംഗവിവേചനവും

India's overall literacy rate has witnessed dramatic progress from a dismal **18.3% in 1951** to over **77%** in recent surveys. However, profound structural disparities persist:

- **Gender Literacy Gap**: Male literacy stands at approximately **84.7%**, whereas female literacy lags near **70.3%**, leaving a glaring **~14% gap**.
- **Regional Disparities**: States like Kerala boast near-universal literacy (**>96%**), whereas northern hinterland states like Bihar lag below **70%**.
- Closing the female education deficit yields monumental demographic dividends by reducing fertility rates and elevating child health.

ഇന്ത്യയുടെ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് **1951 ലെ 18.3% ൽ** നിന്ന് ഇന്ന് **77% ലധികമായി** ഉയർന്നുവെങ്കിലും വലിയ അസമത്വങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു:

- **ലിംഗപരമായ വിടവ്**: പുരുഷ സാക്ഷരത **84.7%** ആയിരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ സാക്ഷരത **70.3%** മാത്രമാണ്; ഏകദേശം **14% വിടവ്** ഇപ്പോഴുമുണ്ട്.
- **പ്രാദേശിക അസമത്വം**: കേരളത്തിൽ സാക്ഷരത **96% ലധികമാണെങ്കിൽ**, ബീഹാർ പോലുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത് **70% ൽ താഴെയാണ്**.
- പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നത് ജനനനിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അടുത്ത തലമുറയുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വഴിതുറക്കുന്നു.

9. Enrolment Metrics: Gross Enrolment Ratio (GER), NER & Dropout Attrition
9. സ്കൂൾ പ്രവേശന സൂചികകൾ: GER, NER & കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് നിരക്ക്

Educational expansion is tracked across stages using specific ratios:

- **Gross Enrolment Ratio (GER)**: Total enrolment in a specific level of education, regardless of age, expressed as a percentage of the official school-age population for that level. While Primary GER exceeds **100%**, Higher Education GER lingers near **28%**.
- **Net Enrolment Ratio (NER)**: Enrolment of the official age group only, revealing exact age-appropriate school coverage.
- **Secondary Dropout Wall**: While primary retention is near universal under the Right to Education Act, secondary school dropout rates spike due to economic pressures and distance to schools.

വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവേശനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി താഴെ പറയുന്ന സൂചികകളിലൂടെ കണക്കാക്കുന്നു:

- **ഗ്രോസ് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ (GER)**: പ്രായപരിധി കണക്കിലെടുക്കാതെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ഘട്ടത്തിൽ ചേരുന്ന കുട്ടികളുടെ ആകെ ശതമാനം. പ്രൈമറി തലത്തിൽ GER **100% ൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും** ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇത് **28% മാത്രമാണ്**.
- **നെറ്റ് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ (NER)**: അതത് പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ മാത്രം അതത് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൃത്യമായ നിരക്കാണിത്.
- **ഹൈസ്കൂൾ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക്**: വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം വഴി പ്രൈമറി തലത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മൂലം കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് കൂടുന്നു.

10. Skill Formation, Vocational Training & Structural Economic Diversification
10. നൈപുണ്യ വികസനം, തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം & ഘടനാപരമായ മാറ്റം

General schooling must be supplemented by vocational and technical capabilities to match modern industrial demands. In developing economies, low skills trap the labor force in subsistence agriculture and informal services.

Under the **Skill India Mission**, expansion of Industrial Training Institutes (**ITIs**), polytechnics, and apprentice frameworks enables workers to transition toward modern high-productivity manufacturing, software engineering, and renewable energy sectors, driving sustainable wage growth.

കേവല അക്ഷരജ്ഞാനത്തോടൊപ്പം വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ നൈപുണ്യവും സാങ്കേതിക പരിശീലനവും നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. നൈപുണ്യമില്ലായ്മ തൊഴിലാളികളെ കുറഞ്ഞ കൂലിയുള്ള അസംഘടിത മേഖലയിൽ തളച്ചിടുന്നു.

സ്കിൽ ഇന്ത്യ മിഷൻ, ITI കൾ, പോളിടെക്നിക്കുകൾ എന്നിവ വഴി തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നത് കൃഷിയിൽ നിന്ന് വ്യവസായ-സേവന മേഖലകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം വേഗത്തിലാക്കുകയും മികച്ച വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

11. The Celebrated "Kerala Model": Social Development vs Moderate Per Capita Income
11. ലോകപ്രസിദ്ധമായ "കേരള മോഡൽ": ഉയർന്ന സാമൂഹിക വികസനവും മിതമായ ആളോഹരി വരുമാനവും

The development trajectory of **Kerala** represents a globally acclaimed paradox in development economics, widely analyzed by **K.N. Raj** and **Amartya Sen**:

- **First-World Social Indicators**: Universal literacy (**>96%**), female literacy (**>95%**), extraordinarily low Infant Mortality (**~6 per 1,000**), and high life expectancy (**75+ years**) matching developed Western nations.
- **Moderate Income Base**: Achieved despite historically moderate industrial growth and per capita GDP, driven by centuries of social reform movements, public schooling investments, land reforms, and a dense public primary healthcare network.

സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ഒരു മാതൃകയാണ് **കേരള മോഡൽ വികസനം (Kerala Model)**; പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരായ **കെ.എൻ. രാജും അമർത്യ സെന്നും** ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്:

- **ഉയർന്ന സാമൂഹിക സൂചികകൾ**: സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത (**>96%**), സ്ത്രീ സാക്ഷരത (**>95%**), വികസിത രാജ്യങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ ശിശുമരണ നിരക്ക് (**~6**), ഉയർന്ന ആയുർദൈർഘ്യം (**75+ വയസ്സ്**).
- **സാമൂഹിക നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിജയം**: ഉയർന്ന വ്യവസായങ്ങളോ വൻ ആളോഹരി വരുമാനമോ ഇല്ലാതെ തന്നെ, സാമൂഹിക നവോത്ഥാനം, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം, ഭൂപരിഷ്കരണം, മികച്ച പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ ശൃംഖല എന്നിവയിലൂടെ കേരളം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചു.

12. Public Expenditure Benchmarks & The Path Ahead: 6% for Education, 2.5% for Health
12. പൊതുചെലവ് ലക്ഷ്യങ്ങളും ഭാവിവഴികളും: വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് 6%, ആരോഗ്യത്തിന് 2.5%

India's developmental leap hinges on meeting constitutional and expert budgetary targets:

- **Kothari Commission (1966) & NEP 2020 Target**: Recommends public investment in education reach **6% of GDP** (currently hovering around **3.1%**).
- **National Health Policy (2017) Target**: Mandates raising public healthcare spending to **2.5% of GDP** (currently near **1.3–1.4%**).
- Public investment in these two foundational social goods creates productive human capabilities that power sustained macroeconomic growth.

ഇന്ത്യയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലുമുള്ള സർക്കാർ ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്:

- **കൊത്താരി കമ്മീഷൻ & NEP 2020 ലക്ഷ്യം**: വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള സർക്കാർ വിഹിതം GDP യുടെ **6% ആയി** ഉയർത്തണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു (ഇപ്പോഴത് **3.1%** മാത്രമാണ്).
- **ദേശീയ ആരോഗ്യ നയം (2017)**: ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതം GDP യുടെ **2.5% ആക്കി** ഉയർത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു (നിലവിൽ **1.3–1.4%**).
- ഈ രണ്ട് മേഖലകളിലെയും നിക്ഷേപം രാജ്യത്തിന്റെ മാനവ ശേഷിയെ ശാക്തീകരിക്കുകയും ദീർഘകാല വളർച്ച ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

📝 MODEL EXAMINATIONS · SHORT ANSWER Q&A (PART 1)

Curriculum Model Questions with Symmetrical Bilingual Answers

പാഠ്യപദ്ധതി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (ഇംഗ്ലീഷ് & മലയാളം പരിഭാഷ)

Q1. Why are health and education considered the twin engines of Human Capital Formation?

ചോദ്യം 1: ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മാനവ മൂലധന രൂപീകരണത്തിന്റെ ഇരട്ട എഞ്ചിനുകളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

Human Capital Formation transforms raw population into productive talent. **Health** supplies physical vitality, cognitive endurance, and uninterrupted working capacity. **Education** imparts literacy, technical competencies, analytical thinking, and adaptability. Working synchronously, they elevate labor productivity and unlock societal innovation.

ജനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ള തൊഴിൽ ശക്തിയാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് മാനവ മൂലധന രൂപീകരണം. **ആരോഗ്യം** ജനങ്ങൾക്ക് ശാരീരികക്ഷമതയും ദീർഘായുസ്സും നൽകുമ്പോൾ, **വിദ്യാഭ്യാസം** സാങ്കേതിക അറിവും നൈപുണ്യവും കാര്യശേഷിയും നൽകുന്നു. ഇവ രണ്ടും സംയോജിക്കുമ്പോഴാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിക്കുന്നത്.

Q2. Distinguish between Infant Mortality Rate (IMR) and Maternal Mortality Ratio (MMR) as development metrics.

ചോദ്യം 2: വികസന സൂചികകളെന്ന നിലയിൽ ശിശുമരണ നിരക്കും (IMR) മാതൃമരണ നിരക്കും (MMR) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമാക്കുക.

IMR measures infant deaths under age one per **1,000 live births**, serving as a direct measure of grassroots sanitation, pure drinking water, immunization, and infant nutrition.

MMR measures maternal pregnancy-related deaths per **100,000 live births**, evaluating institutional maternity facilities, emergency obstetric care, and trained midwife attendance.

ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മരണം **1,000 പ്രസവങ്ങളിൽ** കണക്കാക്കുന്നതാണ് **ശിശുമരണ നിരക്ക് (IMR)**. ശുചിത്വം, കുടിവെള്ളം, വാക്സിനേഷൻ, പ്രാഥമിക ചികിത്സ എന്നിവയുടെ പ്രധാന അളവുകോലാണിത്.

എന്നാൽ പ്രസവത്തോടനുബന്ധിച്ച് അമ്മമാർക്കുണ്ടാകുന്ന മരണം **1,00,000 പ്രസവങ്ങളിൽ** കണക്കാക്കുന്നതാണ് **മാതൃമരണ നിരക്ക് (MMR)**. ആശുപത്രികളിലെ പ്രസവ സൗകര്യങ്ങളുടെയും അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഗുണനിലവാരമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്.

Q3. What are the two central operational pillars of the Ayushman Bharat programme?

ചോദ്യം 3: ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ രണ്ട് പ്രധാന പ്രവർത്തന ഘടകങ്ങൾ ഏവ?

Ayushman Bharat operates through two complementary wings: (1) **Health & Wellness Centres (Ayushman Arogya Mandir)** delivering decentralized primary preventive healthcare, essential diagnostics, and free medicines; and (2) **Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY)** providing cashless health assurance up to **₹5 lakh per family per year** for secondary and tertiary hospitalization.

ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിന്റെ രണ്ട് പ്രധാന തൂണുകൾ: (1) പ്രാഥമിക ചികിത്സയും സൗജന്യ മരുന്നുകളും പരിശോധനകളും നൽകുന്ന **ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ്സ് സെന്ററുകൾ**; (2) പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് കിടത്തിച്ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രതിവർഷം **₹5 ലക്ഷം രൂപ** വരെ സൗജന്യ ക്യാഷ്‌ലെസ്സ് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്ന **പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന (PM-JAY)** ഇൻഷുറൻസ്.

📝 MODEL EXAMINATIONS · SHORT & MEDIUM Q&A (PART 2)

Curriculum Model Questions with Symmetrical Bilingual Answers

പാഠ്യപദ്ധതി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (ഇംഗ്ലീഷ് & മലയാളം പരിഭാഷ)

Q4. Contrast Gross Enrolment Ratio (GER) with Net Enrolment Ratio (NER) in education analytics.

ചോദ്യം 4: വിദ്യാഭ്യാസ സൂചികകളിൽ ഗ്രോസ് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോയും (GER) നെറ്റ് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോയും (NER) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമാക്കുക.

Gross Enrolment Ratio (GER) measures total students enrolled in a specific education level (regardless of age) as a percentage of the official age cohort. It can exceed 100% due to underage or overage students.

പ്രായപരിധി നോക്കാതെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചേരുന്ന ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ ആ പ്രായപരിധിയിലുള്ള ആകെ കുട്ടികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് **GER**. ഇതിന്റെ മൂല്യം 100 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാകാം.

Net Enrolment Ratio (NER) includes only students belonging strictly to the official school-age group, providing an exact measure of age-appropriate schooling coverage without overage distortions.

എന്നാൽ അതത് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കേണ്ട കൃത്യമായ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ മാത്രം സ്കൂളിലെത്തുന്നത് അളക്കുന്ന സൂചികയാണ് **NER**. ഇത് സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കൃത്യത വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

Q5. How does vocational skill formation accelerate structural economic transformation?

ചോദ്യം 5: തൊഴിലധിഷ്ഠിത നൈപുണ്യ വികസനം സാമ്പത്തിക ഘടനയിലെ മാറ്റത്തെ വേഗത്തിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

Developing economies suffer from surplus labor locked in low-productivity agriculture. Vocational training in IT, mechanics, electronics, and precision manufacturing equips young workers with industry-relevant competencies.

വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയൊരു പങ്ക് തൊഴിലാളികളും കുറഞ്ഞ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന കാർഷിക മേഖലയിലാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക വിദ്യ, ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവയിലുള്ള തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനം യുവജനങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വൈദഗ്ധ്യം നൽകുന്നു.

This enables smooth workforce migration from subsistence farming to high-wage modern manufacturing and service sectors, raising aggregate national productivity and household living standards.

ഇത് അവരെ ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ള വ്യവസായ-സേവന മേഖലകളിലേക്ക് മാറാൻ സഹായിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരവും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

Q6. What structural factors explain the extraordinary success of the "Kerala Model" of social development?

ചോദ്യം 6: കേരള മോഡൽ വികസനത്തിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഘടനാപരമായ കാരണങ്ങൾ ഏവ?

Kerala achieved Western-level social indicators despite moderate per capita income due to: (1) historic socio-religious reform movements demanding universal education; (2) state priority for free public schools and female literacy; (3) comprehensive land reforms curbing rural feudalism; and (4) an accessible decentralized primary healthcare network covering every village.

മിതമായ വരുമാനമുണ്ടായിട്ടും കേരളം കൈവരിച്ച വൻ സാമൂഹിക മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണം: (1) വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സാമൂഹിക നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ; (2) സൗജന്യ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും സ്ത്രീ സാക്ഷരതയും; (3) ജന്മിത്തം അവസാനിപ്പിച്ച ഭൂപരിഷ്കരണം; (4) ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന മികച്ച പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ ശൃംഖല.

🎓 COMPREHENSIVE ESSAY ANALYSIS & AUTHENTIC MCQS

Essay Evaluation: Health & Education in Human Development & Curriculum MCQs

പ്രബന്ധ ചോദ്യവും പാഠ്യപദ്ധതിയിലെ പ്രധാന മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളും

Essay: "Social infrastructure—health and education—is superior to physical infrastructure in driving sustained economic progress." Elucidate.

പ്രബന്ധം: "ഭൗതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളേക്കാൾ സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് കരുത്തേകുന്നത് ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവുമടങ്ങുന്ന സാമൂഹിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ്." സമർത്ഥിക്കുക.

While roads, ports, and power plants provide the physical channels of commerce, they remain inert concrete without skilled, healthy human agents to operate them. Investment in education and healthcare directly enhances total factor productivity: an educated population innovates, adapts to frontier technologies, and generates enterprise.

Empirical evidence from East Asian "tiger economies" and Kerala demonstrates that human capability investments break the intergenerational transmission of poverty, curb infant mortality, accelerate demographic transition, and ensure socially inclusive, durable growth far beyond physical capital accumulation.

റോഡുകളും തുറമുഖങ്ങളും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിലും, അവ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ആരോഗ്യവും ബുദ്ധിയുമുള്ള ജനങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. ആരോഗ്യത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുമുള്ള നിക്ഷേപം ജനങ്ങളുടെ നൈപുണ്യവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും കേരളത്തിന്റെയും അനുഭവങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് മാനവ മൂലധനത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും ജനനനിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും വഴിതെളിക്കുന്നു എന്നാണ്.

Curriculum Multiple Choice Questions (Authentic Evaluation)

പാഠ്യപദ്ധതിയിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (MCQs)

1. Life Expectancy at birth mainly indicates: A) Rate of industrial output | **B) Average number of years a person is expected to live** | C) Total literacy rate | D) National export volume
ഉത്തരം: B) ഒരു വ്യക്തി ജീവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ശരാശരി വർഷങ്ങൾ

2. Infant Mortality Rate (IMR) is demographically measured as: A) Death rate of adult laborers | B) Number of operational hospital beds | **C) Deaths of infants under one year per 1,000 live births** | D) Annual population growth rate
ഉത്തരം: C) 1,000 കുട്ടികളിൽ ഒരു വയസ്സിന് താഴെ മരണപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം

3. In developmental economics, Literacy Rate strictly refers to: A) Number of schools built per district | **B) Percentage of population aged 7 and above who can read and write with understanding** | C) University degree enrolment ratio | D) Number of certified teachers employed
ഉത്തരം: B) വായിക്കാനും എഴുതാനും അറിയാവുന്ന ജനങ്ങളുടെ ശതമാനം

4. Vocational skill development initiatives primarily contribute to: A) Curbing fiscal deficits | B) Escalating customs tariffs | **C) Enhancing employability, industrial competencies, and worker productivity** | D) Controlling currency volatility
ഉത്തരം: C) തൊഴിൽ നൈപുണ്യവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു

5. Sustained public investments in Health and Education jointly power: A) Balance of payments deficits | **B) Accelerated Human Capital Formation** | C) Inflationary spirals | D) Foreign exchange reserves volatility
ഉത്തരം: B) മാനവ മൂലധന രൂപീകരണത്തെ വേഗത്തിലാക്കുന്നു

⚡ HIGH-YIELD SYNTHESIS · KNOCK YOUR BRAIN

20 Very Important Knock Your Brain Points on Health & Education

ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും: ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 20 പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

💡 FOUNDATIONAL PILLAR — Human Capital Formation
മാനവ മൂലധന രൂപീകരണം

Schultz and Becker framework of transforming populations through health and knowledge.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും ആരോഗ്യത്തിലൂടെയും ജനങ്ങളുടെ ശേഷി വികസിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ.

⏳ DEMOGRAPHIC INDICATOR — Life Expectancy Growth
ആയുർദൈർഘ്യത്തിലെ വളർച്ച

Rose from 32 years at independence to over 70 years due to vaccines and public hygiene.
സ്വാതന്ത്ര്യ സമയത്തെ 32 വയസ്സിൽ നിന്ന് ഇന്ന് 70 ന് മുകളിലേക്ക് ആയുർദൈർഘ്യം ഉയർന്നു.

👶 SENSITIVE BAROMETER — Infant Mortality Rate (IMR)
ശിശുമരണ നിരക്ക് (IMR)

Deaths under age one per 1,000 live births, reflecting sanitation and maternal health.
ആയിരം ജനനങ്ങളിൽ ഒരു വയസ്സിനു താഴെ മരണപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ നിരക്ക്.

🤰 MATERNAL SAFETY — Maternal Mortality (MMR)
മാതൃമരണ നിരക്ക് (MMR)

Maternal pregnancy deaths per 100,000 live births, testing obstetric hospital quality.
പ്രസവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ലക്ഷം അമ്മമാരിലുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളുടെ കണക്ക്.

🏥 HOSPITAL COVERAGE — Ayushman Bharat PM-JAY
ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഇൻഷുറൻസ്

World's largest assurance scheme providing ₹5 lakh annual hospital cover per family.
പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രതിവർഷം ₹5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്നു.

🩺 PRIMARY HEALTHCARE — Health & Wellness Centres
ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ

150,000+ upgraded rural centres providing free primary diagnostics and essential medicines.
സൗജന്യ മരുന്നുകളും പരിശോധനകളും നൽകുന്ന ഒന്നര ലക്ഷം പ്രാഥമിക കേന്ദ്രങ്ങൾ.

💉 UNIVERSAL IMMUNITY — Mission Indradhanush
മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ്

Intensive immunization drives protecting children and pregnant mothers from fatal diseases.
കുട്ടികൾക്കും ഗർഭിണികൾക്കും സമ്പൂർണ്ണ പ്രതിരോധ കുത്തിവെയ്പ് നൽകുന്ന ബൃഹദ് പദ്ധതി.

🍲 CHILD NUTRITION — Stunting Deficit
വളർച്ചാ മുരടിപ്പ് (Stunting)

Low height-for-age reflecting chronic undernutrition, permanently harming brain potential.
പോഷകാഹാരക്കുറവ് മൂലം പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉയരമുണ്ടാകാത്ത അവസ്ഥ.

⚖️ NUTRITION METRIC — Child Wasting
ശരീരശോഷണം (Wasting)

Low weight-for-height indicating acute recent malnutrition and infectious disease.
ഉയരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഭാരക്കുറവ്; കടുത്ത പോഷകാഹാരക്കുറവിന്റെ ലക്ഷണം.

🧠 CAPABILITY THEORY — Amartya Sen Freedom
ശേഷി വികാസ സിദ്ധാന്തം

Education is an intrinsic capability enabling citizens to lead lives of genuine value.
മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വാതന്ത്ര്യവും ചിന്താശേഷിയും വികസിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം.

📖 EDUCATIONAL METRIC — National Literacy Rise
സാക്ഷരതയിലെ കുതിച്ചുചാട്ടം

Overall literacy expanded from 18.3% in 1951 to over 77% in recent national censuses.
സാക്ഷരത 1951 ലെ 18.3% ൽ നിന്ന് ഇന്ന് 77% ലധികമായി വർദ്ധിച്ചു.

🚻 SOCIAL IMBALANCE — Gender Literacy Gap
ലിംഗ സാക്ഷരതാ വിടവ്

Male literacy (~84.7%) outpaces female literacy (~70.3%) by an unacceptable ~14% margin.
പുരുഷ സാക്ഷരതയേക്കാൾ 14 ശതമാനത്തോളം പിന്നിലാണ് ഇപ്പോഴും സ്ത്രീ സാക്ഷരത.

🎒 ENROLMENT METRIC — Gross Enrolment Ratio (GER)
ഗ്രോസ് എൻറോൾമെന്റ് നിരക്ക്

Total enrolment as percentage of eligible age group; high in primary, low in tertiary.
സ്കൂളുകളിൽ ചേരുന്ന കുട്ടികളുടെ ശതമാനം; പ്രൈമറിയിൽ ഉയർന്നതും കോളേജുകളിൽ കുറവും.

🎯 AGE PRECISION — Net Enrolment Ratio (NER)
നെറ്റ് എൻറോൾമെന്റ് നിരക്ക്

Measures only age-appropriate children enrolled in class, eliminating age distortions.
അതത് പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ അതത് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൃത്യമായ നിരക്ക്.

⚙️ INDUSTRIAL SKILL — Vocational Skill Mission
തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം

Technical training via ITIs to move surplus farm labor into high-productivity jobs.
കാർഷിക തൊഴിലാളികളെ വ്യവസായ മേഖലയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന സാങ്കേതിക പരിശീലനം.

🏆 GLOBAL BENCHMARK — The Kerala Model
കേരള മോഡൽ വികസനം

First-World social indicators (96% literacy, low IMR) despite moderate per capita income.
ഉയർന്ന ആളോഹരി വരുമാനമില്ലാതെയും വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ നേട്ടം കൈവരിച്ച മാതൃക.

💰 BUDGET TARGET — 6% of GDP for Education
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് 6% വിഹിതം

Historic Kothari Commission and NEP 2020 target to fund quality public schooling.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി GDP യുടെ 6 ശതമാനം ചെലവഴിക്കണമെന്ന ദേശീയ നയ ലക്ഷ്യം.

🏥 HEALTH INVESTMENT — 2.5% of GDP for Health
ആരോഗ്യത്തിന് 2.5% വിഹിതം

National Health Policy 2017 mandate to reduce catastrophic household medical spending.
പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനായി GDP യുടെ 2.5 ശതമാനം ബജറ്റിൽ മാറ്റിവെക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം.

🏗️ INFRASTRUCTURE EDGE — Social vs Physical Capital
സാമൂഹിക മൂലധനത്തിന്റെ മേന്മ

Human capital investments yield superior, enduring total factor productivity over concrete.
റോഡുകളേക്കാൾ രാജ്യത്തിന്റെ ദീർഘകാല പുരോഗതിക്ക് കരുത്തുപകരുന്നത് ജനങ്ങളുടെ അറിവാണ്.

🌟 HOLISTIC GOAL — Means & End of Growth
വികസനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും മാർഗ്ഗവും

Healthy and educated citizens are the driving engine and ultimate purpose of development.
ആരോഗ്യവും അറിവുമുള്ള ജനങ്ങളാണ് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ ഉപാധിയും പരമമായ ലക്ഷ്യവും.